Mission de structuration documentaire

Santé numérique

Rapport de cadrage et recommandations
à destination du client

Selyan Mouhali

Mars 2026

Version 1.0

Document confidentiel

Prototype d'interface consultable en ligne :
https://github.com/selyan-mhli/mission-sante-numerique

Table des matières

1 Contexte et enjeux **2**
1.1 Présentation du client 2
1.2 Le besoin identifié 2
1.3 Signaux en faveur d'une approche progressive 2

2 Analyse des options et choix stratégique **2**
2.1 Deux approches possibles 2
2.2 Comparaison détaillée 3
2.3 Recommandation : Option A – COSI 3

3 Notre plus-value concrète **3**

4 Plan d'action proposé **4**

5 Prototype d'interface – Aperçu phase 2 **5**
5.1 Ce que montre le prototype 5
5.2 Accès au prototype 5
5.3 Ce que le prototype ne fait pas 5

6 Quand une interface complète deviendrait pertinente **5**

7 Points de vigilance **6**

8 Conclusion et message clé **6**

1. Contexte et enjeux

1.1 Présentation du client

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une **association dédiée au numérique en santé**, en lien avec un écosystème de partenaires potentiels : hôpitaux, médecins, institutions publiques de santé.

L'association dispose d'un **corpus documentaire estimé entre 100 et 200 fichiers**, constitué au fil du temps dans des formats hétérogènes : principalement **Word** et **PowerPoint**, avec quelques PDF. Ces documents couvrent des sujets variés : télésurveillance, interopérabilité, stratégie e-santé, sécurité des données, coordination des soins, etc.

1.2 Le besoin identifié

L'analyse des échanges et des éléments fournis met en évidence un besoin prioritaire :

Besoin principal

Mise en ordre et exploitation d'un fonds documentaire hétérogène : classer l'existant, rendre la base consultable, et préparer des usages futurs d'aide à la rédaction par IA pour de nouveaux contributeurs.

Le projet doit être lu comme un **sujet d'architecture de l'information** : définir une logique de tri, de nommage, de taxonomie et de métadonnées, puis choisir le meilleur véhicule pour l'opérationnaliser.

1.3 Signaux en faveur d'une approche progressive

Plusieurs éléments convergent vers une approche par étapes plutôt que par un développement immédiat :

— Le corpus reste de **taille raisonnable** (100 à 200 documents) ;
— Les **6 axes de tri ne sont pas encore définis**, ce qui signifie que le modèle documentaire n'est pas stabilisé ;
— L'IA est une **perspective future**, pas un besoin de production immédiat ;
— Les formats majoritaires (Word, PowerPoint) sont des contenus riches mais hétérogènes, qui **nécessitent une normalisation** avant tout outillage avancé.

2. Analyse des options et choix stratégique

2.1 Deux approches possibles

Deux trajectoires ont été évaluées pour répondre au besoin du client :

— **Option A** — Classification et structuration via COSI (environnement existant) ;

— **Option B** — Développement d'une interface web complète sur mesure.

2.2 Comparaison détaillée

Critère	Option A – COSI	Option B – Interface web
Objet	S'appuyer sur un environnement existant pour classer, indexer et gouverner le fonds documentaire.	Construire un produit dédié pour consulter, filtrer, rechercher et contribuer.
Valeur immédiate	**Forte** : on traite le problème racine (structuration).	Visible mais indirecte : l'interface peut masquer un fond mal organisé.
Effort / délai	Maîtrisable, rapide à lancer, forfait défendable.	Plus lourd : cadrage UX, sécurité, droits, maintenance.
Risque	Modéré : périmètre clair, meilleure marge.	Élevé : dérive, scope creep, incompréhension MVP.
Pertinence à 200 docs	**Très bonne.**	Faible à moyenne : potentiellement surdimensionnée.
Évolutivité	Très bonne : prépare le RAG et une future interface.	Bonne à long terme, si structure stabilisée.

2.3 Recommandation : Option A – COSI

Notre recommandation

Privilégier une **phase 1 de structuration via COSI**, avec taxonomie, métadonnées, 6 axes de tri et préparation des futurs usages IA.

COSI n'est pas la valeur en soi, mais le **véhicule le plus rationnel** pour déployer rapidement une base documentaire structurée. L'intérêt est d'éviter un développement sur mesure trop précoce, tout en disposant d'une GED, d'un moteur de recherche, d'une arborescence et de droits d'accès déjà disponibles.

La plus-value ne réside pas dans l'outil, mais dans la **conception du système documentaire** qui vivra dedans.

3. Notre plus-value concrète

Le travail de structuration apporte une valeur directe et mesurable :

1. **Définir les 6 axes de tri** pertinents pour la santé numérique :

- Type de document (guide, fiche, étude, cahier des charges…)
- Thématique (télésurveillance, interopérabilité, sécurité…)
- Public cible (professionnels de santé, DSI, institutionnels…)
- Source / partenaire
- Niveau de confidentialité (public, interne, restreint)
- Statut / maturité (brouillon, en cours, validé)

2. **Construire une taxonomie claire** adaptée au secteur de la santé numérique ;
3. **Définir les métadonnées** obligatoires et optionnelles pour rendre la base interrogeable ;
4. **Organiser le corpus** pour que les futurs contributeurs retrouvent rapidement les bons matériaux de référence ;
5. **Préparer le terrain** pour une future recherche sémantique, un RAG ou une aide à la rédaction assistée par IA.

4. Plan d'action proposé

La mission se décompose en **5 étapes** séquentielles et cohérentes :

Étape	Contenu
Phase 1 – Audit ciblé	Inventorier le corpus, identifier les grandes familles documentaires, repérer doublons, versions et documents sensibles.
Phase 2 – Modèle documentaire	Définir les 6 axes de tri, la taxonomie, les règles de nommage et les métadonnées obligatoires / optionnelles.
Phase 3 – Implémentation COSI	Créer l'arborescence, les catégories, les filtres utiles et les règles de classement dans l'environnement COSI.
Phase 4 – Préparation IA	Structurer les contenus pour rendre possible ensuite une recherche augmentée et une aide à la rédaction.
Phase 5 – Démo visuelle	Montrer une interface de projection pour illustrer la phase 2 potentielle sans surpromettre un développement complet.

5. Prototype d'interface – Aperçu phase 2

Afin de rendre tangible la trajectoire proposée, nous avons réalisé un **prototype fonctionnel d'interface web**. Ce prototype illustre ce que pourrait devenir la base documentaire une fois structurée, si le client souhaite aller vers une exploitation avancée.

5.1 Ce que montre le prototype

- **Tableau de bord** avec indicateurs clés (nombre de documents, thématiques, sources, taux de structuration) ;
- **Moteur de recherche** plein texte avec filtrage instantané ;
- **6 axes de filtres** fonctionnels (type, thématique, public, source, confidentialité, statut) ;
- **12 documents fictifs réalistes** liés à la santé numérique, avec métadonnées complètes ;
- **Assistant IA simulé** montrant des cas d'usage concrets :
  - Synthèse automatique de documents par thématique ;
  - Aide à la rédaction pour de nouveaux contributeurs ;
  - Identification de contenus pour un partenariat institutionnel.
- **Feuille de route visuelle** avec timeline phase 1 / phase 2.

5.2 Accès au prototype

Le prototype est consultable en ligne via le dépôt GitHub du projet :

Lien vers le prototype

https://github.com/selyan-mhli/mission-sante-numerique

Il s'agit d'un fichier HTML autonome, sans backend ni framework, ouvrable directement dans un navigateur. Le code source est documenté et versionné.

5.3 Ce que le prototype ne fait pas

Il est important de préciser que ce prototype est une **projection visuelle** :

- Il ne contient pas de vraie intelligence artificielle ;
- Il ne se connecte à aucune base de données ;
- Il ne remplace pas le travail de structuration de la phase 1 ;
- Il sert uniquement à **rendre concret** le potentiel d'une base documentaire bien structurée.

6. Quand une interface complète deviendrait pertinente

Une plateforme web dédiée deviendrait légitime dans les cas suivants :

— Le **volume documentaire augmente** fortement au-delà de 200 documents ;
— **Plusieurs profils** doivent contribuer ou consulter simultanément ;
— Des **workflows éditoriaux** (validation, relecture, publication) sont nécessaires ;
— Le client souhaite exposer un **portail à des partenaires externes** (hôpitaux, institutions).

Point important

Dans ce scénario, le **socle défini en phase 1 resterait intégralement réutilisé** : taxonomie, axes de tri, métadonnées et arborescence serviraient de fondation à la plateforme.

7. Points de vigilance

Pour garantir la réussite du projet, certains écueils doivent être évités :

— **Ne pas promettre** une plateforme complète en peu de temps sans avoir validé les usages réels ;
— **Ne pas brancher** une IA directement sur des données sensibles sans cadrage sécurité et conformité ;
— **Ne pas automatiser** le classement sans travail humain sur la taxonomie et les règles documentaires ;
— **Ne pas présenter** un RAG ou une base vectorielle comme solution miracle avant d'avoir nettoyé et structuré le corpus.

8. Conclusion et message clé

Pour cette phase, la meilleure approche est de proposer une **mission de structuration documentaire via COSI**. C'est l'option :

— la plus **rentable** pour le prestataire ;
— la plus **réaliste** pour le client ;
— la plus **simple à défendre** : elle produit une valeur immédiate, réduit le risque de faux départ et prépare une future couche d'interface web ou d'IA si le besoin se confirme.

Message clé

« Avec 100 à 200 documents, le bon investissement n'est pas de développer trop tôt une plateforme complète, mais de structurer d'abord un actif documentaire exploitable, retrouvable et prêt pour l'IA. »

—

Document rédigé par Selyan Mouhali — Mars 2026
Prototype disponible sur `https://github.com/selyan-mhli/mission-sante-numerique`